

• 临床用药 •

阿替洛尔的 药物相互作用

大连医学院附属第一医院药剂科(116011) 徐永昭

阿替洛尔(Atenolol)又称氨酰心胺,是一种新型 β 受体阻滞剂,主要用于治疗高血压、心绞痛等病。现将其药物相互作用综述如下。

一、阿替洛尔+硫氮革酮

据报道,1例51岁的女性病人,合用消心痛和阿替洛尔疗效不满意,停用阿替洛尔,改为硫氮革酮30mg,3次/日,未出现心律失常,1小时后,患者自服阿替洛尔25mg,约1小时后,患者突感胸闷、出汗,血压下降,心率加快,心律不齐等反应。作者认为,阿替洛尔降低了窦房结的活性,硫氮革酮产生了对窦房结的抑制而造成窦性停搏,两者合用要慎重^[1]。

二、阿替洛尔+西米替丁

两者均由肾脏排泄清除,西米替丁不影响阿替洛尔经肾脏药代动力学及生物效应,两者不产生相互作用,可以合用^[2]。

三、阿替洛尔+苄氟噻嗪

有人报道24例卧位舒张压大于12kPa的病人,用阿替洛尔200mg/d,加服苄氟噻嗪5mg/d治疗,比两者单用降压效果好。还有报道,21例高血压病人,两者合并治疗,降压效果明显^[3]。

四、阿替洛尔+甲基多巴

两者合用时,降压效果比单用明显,如阿替洛尔150mg与甲基多巴750mg/d合用时比单用阿替洛尔150mg/d和300mg/d,单用甲基多巴70mg/d和150mg/d时血压下降显著^[3]。

五、阿替洛尔+肼苯哒嗪

有人报道,29例中、重度高血压病人,服用阿替洛尔(50mg或100mg)、苄氟噻嗪(2.5mg)和肼苯哒嗪(50mg)三者合并治疗,对降低立位舒张压的疗效,明显优于前两者的联合治疗^[3]。

六、阿替洛尔+哌唑嗪

服用阿替洛尔(100mg/d)时,加服哌唑嗪(6mg/d或15mg/d),对降卧位、立位、运动时血压,比单一用药为佳(约下降16%)。还有人报道,有10例高血压病人,接受阿替洛尔、苄氟噻嗪和哌唑嗪三者联合治疗,其效果比前两者合并治疗为好^[3]。

七、阿替洛尔+硝苯吡啶

两者合用治疗心功能不全的病人,对明显造血外因子低下和左心室舒张末期压力增高者,有加重心衰的作用。故两者合用要慎重^[4]。

八、阿替洛尔+异搏定

有人报道,两者合并治疗10例稳定型冠状动脉病者,服药1~3小时后血压降到最低值,心电图PR间期轻度延长,部分患者阿替洛尔稳定状态血浓度有不同程度增高,其最高浓度变化范围为-30~+144%,血浆药物浓度曲线下面积为-10~+112%,但平均值变化并不明显。2例加用阿替洛尔静注的病人,其肾廓清率降低35%以上,药物动力学相互作用程度与血液动力学改变之间无相关性。作者指出,个别病人可出现阿替洛尔与异搏定药代动力学相互作用,此种病人不宜采用联合治疗,这与肝、肾功能状态有关^[5]。

九、阿替洛尔+特拉唑嗪

两者合用时,增压作用增强($P < 0.01$),卧位、立位血压分别下降8.8/8.5kPa和10.9/9.5kPa,安慰剂与阿替洛尔合用血压无明显下降。两者合用对原发性高血压有效而安全,特拉唑嗪的血管扩张作用导致心率加快,而从抵消了阿替洛尔的减慢心率的作用^[6]。

十、阿替洛尔+阿斯匹林

有人报道,阿替洛尔(100mg)和阿斯匹林(500mg)合用时,对阿替洛尔的动力学及药效学无影响^[7]。

十一、阿替洛尔+别嘌呤醇

据文献指出,阿替洛尔与别嘌呤醇合用时,对阿替洛尔的动力学及药效学也无影响^[7]。

十二、阿替洛尔+氨苄青霉素

有人报道,阿替洛尔(100mg)和氨苄青霉素(1g)合用后,Cmxo降至 $344 \pm 33\text{ng/ml}$,曲线下面积从 $5818 \pm 476\text{ng/ml} \cdot \text{h}$ 降至 $3459 \pm 303\text{ng/ml} \cdot \text{h}$,生物利用度从 $60 \pm 8\%$ 降至 $36 \pm 5\%$,累积尿药排泄量从 $40 \pm 6\text{mg}$ 降至 $35 \pm 6\text{mg}$,但并不改变阿替洛尔 $t_{1/2}$ 和肾清除率。对运动性心动过速,在用药后6小时之内,对是否合用氨苄青霉素,影响不大,但在用后12小时,两者差异显著。单用阿替洛尔,心率平均为 139 ± 6 次/分,两者合用后,心率平均达 160 ± 6 次/分。对血压影响不显著。作者认为,两者合用时,为保证阿替洛尔的

疗效,用量应加倍^[7]。

参考文献

1. 刘 健. 硫氮革酮与氨酰心胺并用致室性停搏一例. 中国循环杂志 1988;3(1):21.
2. 施陈刚,等. H₂受体拮抗剂与心血和药物的相互作用. 辽宁医学杂志 1991;55(4):213.
3. 徐济民. 阿替洛尔国外临床应用进展. 新药与临床 1988;7(5):278.
4. Michaelde Buifleur et al. Hemodynamic effect of nifedipine

given alone and in combination with atenolol in patient with impaired left ventricular function. Am J Cardiol 1985;55(12):1513.

5. 氨酰心胺与异搏定相互作用因人而异. 中国医学论坛报 1989;5(5):103.
6. 胡琛. 特拉唑嗪和阿替洛尔联合治疗原发性高血压. 国外药合成药、生化药、制剂分册 1989;10(4):244.
7. 李丙阳. 氨酰心安与阿斯匹林、别嘌呤醇及氨苄青霉素间的相互作用. 药学通报 1984;19(2):56.

速尿加黄体酮治疗输尿管结石 86 例报告

解放军第 406 医院一外科(116041) 张德玉 吕逢宽 姜立业 吕爱琴

我院自 1989 年开始,应用速尿加黄体酮治疗输尿管结石 86 例,取得较满意的治疗效果,报告如下。

临床资料

一、一般资料:本组 86 例,男 71 例,女 15 例。年龄 22~61 岁。病史最长 10 年,有绞痛史 75 例。肉眼血尿 24 例,镜下血尿 49 例。腹部 X 线平片发现不透光结石者 63 例,静脉肾盂造影发现阴性结石者 11 例。结石位于输尿管上段 15 例,中段 18 例,下段 41 例,3 例合并有肾结石。

二、治疗方法:静脉快速滴入 10%葡萄糖液 1000ml,余 200ml 液体时加入速尿 80mg,并适当减慢滴入速度。在加速尿前半小时肌肉注射黄体酮 40mg。液体输完后,适当增加活动量。10 天为一疗程,间隔 3~5 天后开始第二疗程。

治疗期间内,口服 10%氯化钾液 10ml,3 次/日,并定期复查血离子。

三、治疗结果:本组 86 例中 63 例经治疗后于 2~45 天排出结石,最大 1.1×0.8cm,最小 0.3×0.3cm。经腹部 X 线平片及静脉肾盂造影证实原结石影消失者 12 例,结石阴影下移超过 5cm 者 7 例。其中 10 例临床有肾绞痛发作及镜下血尿,但腹部 X 线平片及静脉肾盂造影均未发现结石,经治疗后有 8 例排出米粒或绿豆大小结石。本组尚有 8 例次输尿管上段结石,行体外冲击波碎石(ESWL)碎石后,应用本法治疗,均在 1~5 天内排出较多结石碎片,且绞痛和血尿亦在用药后完全消失。此外,尚有 11 例服消石素及其它方法治疗无效,经本方法治疗后有 7 例排出结石。在治疗期间病人均无绞痛及血尿发生,本组 5 例在用药后出现头晕、无力、心慌,3 例出现性欲减退,停药后上述不适均迅速消失。

讨 论

应用黄体酮治疗输尿管结石国内已有报道^[1],因黄体酮有使输尿管平滑肌松弛、扩张及产生节律性蠕动的作用。我们经临床应用后发现黄体酮治疗肾绞痛效果较好,但结石排出率不高。因此,我们在应用黄体酮的基础上,同时应用速尿。速尿有增加近曲小管、肾小球滤过及抑制髓质部、皮质部对钠的再吸收,而起到利尿作用^[2],静脉注射后 0.5~1.5 小时发挥最大作用。黄体酮肌肉注射后 30~60 分钟输尿管平滑肌出现松弛、扩张,1~2 小时开始产生有力的节律性蠕动,加上速尿的利尿性冲击,两者共同作用,促使结石排出。其临床效果,对病史短,结石较小的病人,尤为满意。本组 8 例行(ESWL)后病人,经本方法治疗,结石均迅速排出,且无绞痛及血尿的发生。似说明结石被粉碎后,尚未被包裹,与输尿管无粘连^[3],是本方法的适应证。因速尿有排钾、排钠作用,因此,在治疗期间我们常规给病人每日口服钾盐,以防止低血钾。本组病例多次复查,其血清钾、钠均在正常范围之内。通过临床应用,我们认为本治疗方法的适应证为:①患者身体状况好,无其它脏器疾病;②病史短,结石横径小于 0.8cm;③无严重的肾积水或肾功能不全;④作为 ESWL 碎石后的辅助治疗。此治疗方法简单,排石率较高,止痛效果好,副作用较少,宜于推广使用。

参考文献

1. 董德生,等. 黄体酮治疗输尿管结石的临床总结和实验研究,中华外科杂志 1986;24(2):77.
2. 陈新谦,等主编. 新编药理学. 第 12 版. 北京:人民卫生出版社,1985:462.
3. 蔡行正,等. ESWL 的并发症. 中华泌尿外科杂志,1991;12(3):188.